ВСЯКА СЕДМИЦА ПО ЕДИН СЛУЧАЙ™ · БОНУС 3

Шаблони за представяне на случаи пред колеги

Готови структури, шаблони с квадратни скоби и чеклист за записите, за да представите случай подредено за 60 секунди, 5 минути или на постер.

Съдържание

Преди представянето: четири правила

60-секундно представяне

5-минутно представяне

Постерно представяне

Писмено запитване за мнение от колега

Чеклист за записите: снимки, модели, рентгенографии

Сравнение преди / след

Чести грешки при представяне

Следваща стъпка

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ

Преди представянето: четири правила

Какъвто и да е форматът, гръбнакът е един и същ.

1. **Определете един въпрос.** „Какво искам от Вас по този случай?“ Мнение, решение или обучение? Първото и последното изречение на представянето се свързват с този въпрос.
2. **Използвайте един и същ ред.** Идентификация и оплакване → находки → списък на проблемите → план → въпрос или резултат.
3. **Анонимизирайте пациента.** Премахнете идентификатори като име, номер на картон и дата. За снимки на лицето вижте формуляра за съгласие, който използва Вашата клиника.
4. **Запишете да са стандартни.** Същият ъгъл, същата светлина, същият ред. Отметнете чеклиста за записите преди представянето.

ФОРМАТ	КОГА	ОСНОВНА ЦЕЛ
60 секунди	Кратка консултация в клиниката, разговор в коридора	Мнение за едно конкретно решение
5 минути	Клинична среща по случаи, работна група	Обсъждане на плана или представяне на завършен случай
Постер	Конгреси и научни събития	Случаят да се разбира с един поглед

ФОРМАТ 1

60-секундно представяне

Четири блока, всеки с едно-две изречения.

ВРЕМЕ	БЛОК	СЪДЪРЖАНИЕ
0–10 сек	Идентификация и оплакване	Възраст, пол, растежен статус, оплакване с думите на пациента.
10–30 сек	Основни находки	Моларно/кучешко съотношение, overjet/overbite, скупченост, две-три цефалометрични стойности, важна анамнеза.
30–45 сек	Проблем и варианти	Най-важният проблем и двата варианта, които обмисляте.
45–60 сек	Въпрос	Какво точно искате от колегата си.

Шаблон

[Възраст] г., **[растежен статус]** — **[момиче / момче / жена / мъж]**. Оплакване: "**[изречението на пациента]**".

Моларно съотношение **[дясно / ляво]**, overjet **[mm]**, overbite **[mm]**. Скупченост горе **[mm]**, долу **[mm]** . ANB **[°]**, FMA **[°]**. Важна анамнеза: **[навик / травма / общо здраве]**.

Според мен основният проблем е **[проблем]**. Обмислям два варианта: **[вариант 1]** или **[вариант 2]**.

Искам да Ви попитам: **[един ясен въпрос]**?

Попълнен пример (измислен)

Момче на 13 години, близо до пубертетния скок на растежа. Оплакване: "Зъбите ми са напред."

Моларно съотношение двустранно пълен клас II, overjet 8 mm, overbite 5 mm. Скупченост горе 4 mm, долу 3 mm. ANB 6°, FMA 25°. Преди година — фрактура на короната на горен централен резец.

Според мен основният проблем е клас II, дължащ се на мандибуларна ретрузия, и увеличен overjet. Обмислям два варианта: начало с функционален апарат или екстракционен камуфлаж след края на растежа.

Искам да Ви попитам: при този пациент с анамнеза за травма бихте ли започнали функционален апарат сега?

ФОРМАТ 2

5-минутно представяне

10 слайда, общо около 5 минути. На всеки слайд една идея.

СЛАЙД	ВРЕМЕ	ЗАГЛАВИЕ	СЪДЪРЖАНИЕ
1	30 сек	Заглавие и въпрос	Заглавие на случая и единственият въпрос или основното послание на представянето.
2	30 сек	Идентификация и оплакване	Възраст, растежен статус, оплакване, свързана анамнеза.
3	40 сек	Екстраорални снимки	Анфас в покой, анфас с усмивка, профил. Коментар на профила в едно изречение.
4	40 сек	Интраорални снимки	Фронтална, дясна, лява, горна и долна оклузална. Находките от захапката по ред.
5	30 сек	Рентгенографии	Находки от ОПГ (по реда на Инструмент 1) и латерална цефалограма.
6	30 сек	Цефалометрично обобщение	Осем измервания и коментар в три изречения: сагитално, вертикално, дентално.
7	30 сек	Списък на проблемите	Сагитално, вертикално, трансверзално, място и оплакване на пациента.
8	30 сек	Цели и план	Цели, варианти и избран план; обосновка.
9	20 сек	Ход или резултат	При текущ случай — настоящият етап; при завършен — преди/след.
10	20 сек	Въпрос или урок	Въпрос за дискусия или урок от този случай.

Слайд със списъка на проблемите · шаблон

Сагитално: [моларно/кучешко съотношение, overjet, скелетен произход]

Вертикално: [overbite, вертикален модел]

Трансверзално: [кръстосана захапка, средни линии]

Място: [горна и долна скупченост/пространство, mm]

Оплакване на пациента: [изречението на пациента]

Слайд с плана · шаблон

Цели: 1) [цел] 2) [цел] 3) [цел]

Варианти: A) [вариант] · B) [вариант]

Избран план и обосновка: [план], защото [обосновка].

Анкораж и ретенция: [план за анкораж] · [план за ретенция]

ФОРМАТ 3

Постерно представяне

Толкова малко текст, че да се чете от метър, и толкова ясна подредба, че да се разбира с един поглед.

Заглавие

[Заглавие, описващо случая в едно изречение] · [Институция или клиника, във формата, изискван от събитието]

Въведение

[Защо случаят е интересен, 2–3 изречения]

Данни за случая

[Възраст, оплакване, анамнеза; екстраорални и интраорални снимки]

Диагноза

[Таблица с цефалометрично обобщение и списък на проблемите]

План

[Цели, варианти и избран план]

Ход на лечението

[Етапи и продължителност; междинни снимки]

Резултат

[Снимки преди / след, сравнение с финалната цефалометрия]

Дискусия и научени уроци

[2–3 урока от този случай; кратко и конкретно]

Чеклист за постера

- [ ] Прочетох правилата на събитието за размер и формат.
- [ ] Всеки раздел — най-много няколко кратки изречения.
- [ ] Снимките са под същия ъгъл и светлина, преди/след една до друга.
- [ ] Цефалометричните стойности са в таблица, не се повтарят в текста.
- [ ] Идентификаторите на пациента са премахнати; съгласието е взето с формуляра, който използва Вашата клиника.
- [ ] Заглавието се чете отдалеч.

ШАБЛОН

Писмено запитване за мнение от колега

Кратко, подредено и фокусирано върху един въпрос съобщение получава по-бърз и по-ясен отговор.

До колега ортодонт

[Име на колегата] — здравейте,

Бих искал/а да чуя накратко мнението Ви за един случай. **[Възраст]** -годишен пациент, **[растежен статус]** . Основни находки: **[моларно съотношение, overjet, overbite, скупченост]**; ANB **[°]**, FMA **[°]**.

Колебая се между два варианта: **[вариант 1]** и **[вариант 2]**. Аз клоня към **[вариант]**, защото **[обосновка]**.

Въпросът ми: **[един въпрос]**? Прилагам анонимизираните записи.

Благодаря, **[Вашето име]** · **[Име на клиниката]**

Консултативна бележка до хирург, пародонтолог или протетик

Пациент: **[код на картона]**, **[възраст]** · **Причина за консултацията:** **[напр. оценка на хирургичен вариант / потвърждение на пародонтална стабилност / план за място на имплант]**

Ортодонтски находки: **[кратко обобщение]**

Ортодонтски план: **[планирани движения на зъбите и очаквани етапи]**

Какво очаквам от Вас: **[ясен въпрос или потвърждение]**

Приложения: **[снимки, рентгенографии, цефалометрично обобщение]**

ЧЕКЛИСТ

Чеклист за записите

Един и същ списък при всеки начален, междинен и финален запис. Попълнете липсите преди представянето.

Екстраорални снимки

- [ ] Анфас, в покой
- [ ] Анфас, с усмивка
- [ ] Профил, в покой
- [ ] Усмивка в три четвърти
- [ ] При нужда отдолу (за асиметрия)

Интраорални снимки

- [ ] Фронтална, в захапка
- [ ] Дясна букална
- [ ] Лява букална
- [ ] Горна оклузална
- [ ] Долна оклузална
- [ ] Изглед на overjet (отстрани)

Модели

- [ ] Пълен запис на горната и долната дъга (дигитален или гипсов)
- [ ] Финален запис
- [ ] При нужда регистрат в централна релация
- [ ] Резултати от анализа на мястото и Bolton

Рентгенографии

- [ ] ОПГ (разчетена по реда на Инструмент 1)
- [ ] Латерална цефалограма и трасиране
- [ ] Допълнителни изследвания според показанията
- [ ] Междинни и финални рентгенографии

Стандарт за снимките

- [ ] Същият фон и светлина; без отражения.
- [ ] Главата в естествена позиция; на профилната снимка Франкфуртската равнина е приблизително успоредна на пода.
- [ ] Използването на ретрактори и огледала за интраоралните снимки е еднакво при всеки запис.
- [ ] Без име на пациента в имената на файловете; кодът на картона в клиниката и етапът на записа (начало / междинен / край).

ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТ

Сравнение преди / след

Еднакви условия, за да се покаже промяната честно.

ПРАВИЛО	ЗАЩО
Същият ъгъл и същото увеличение	Различният ъгъл може да преувеличи или да скрие промяната.
Същата светлина и фон	Разликата в цвета и контраста се възприема като промяна.
Едно до друго или насложени	Зрителят трябва да може сам да направи сравнението.
Дайте цефалометричните стойности в таблица	Начало, край и разлика в три колони.
Посочете ограниченията	Посочването и на непостигнатите цели прави представянето достоверно.

Таблица за цефалометрично сравнение · шаблон

ИЗМЕРВАНЕ	НАЧАЛО	КРАЙ	РАЗЛИКА
SNA			
SNB			
ANB			
Wits			
FMA			
SN-GoMe			
IMPA			
U1-SN			

ИЗБЯГВАЙТЕ

Чести грешки при представяне

Корекция в едно изречение за всяка.

ГРЕШКА	КОРЕКЦИЯ
Оставяне на въпроса за накрая	Задайте въпроса в първото изречение и го повторете в последното.
Прочитане на всички цефалометрични стойности	Осем измервания в таблицата, устно — само коментар в три изречения.
Прескачане на списъка на проблемите и започване с апарата	Първо списък на проблемите и цели, после механика.
Снимки преди/след под различен ъгъл и светлина	Прилагайте чеклиста за записите още в началото.
Оставяне на идентификатори на пациента на слайда	Проверете всичко преди представянето, включително имената на файловете.
Представяне само на успешни случаи	Представянето на заседнал случай често е по-поучително.
Превишаване на времето	Направете една репетиция на глас, с хронометър.

С образователна цел. Не замества клиничната преценка на специалиста.

Следваща стъпка

Изберете случай тази седмица и попълнете 60-секундния шаблон. За упражнение по представяне са идеални случаите от 52-седмичната програма за работа по случаи — **Седмици 49–52** .

За слайда с цефалометричното обобщение използвайте метода с три изречения от **Тетрадка за упражнения по цефалометрични измервания**. За списъка на проблемите и плана отворете в Библията **Инструмент 4 · Клиничен планер в 4 етапа**.